1. Objetivo:

Padronizar a preparação e os cuidados por tipo de cirurgia a ser realizada.

2. Responsável:

Equipe de enfermagem.

3. Tipos de Cirurgia:

- Lipoaspiração com tecnologias (Renuvuion, Morpheus, Vaser;
- Lipoaspiração com abdominoplastia/mini abdominoplastia e tecnologias;
- Mastopexia com Próteses;
- Mastopexia com próteses e lipoaspiração nas laterais das mamas;
- Mastopexia com Próteses e Lipoaspiração nas laterais das mamas, frente e nas costas;
- Prótese de Mama R24R;
- Prótese de Mama R24R + Lipoaspiração;
- Lipoaspiração com Tecnologias + Mastopexia com Próteses.

3.1. Lipoaspiração com tecnologias (Renuvion):

Preparo da sala:

- Levar Renuvion e vaser, posicionar à esquerda da mesa cirúrgica;

- Os aparelhos deverá ficar posicionada de modo a permitir a execução dos movimentos de lipoaspiração no lado esquerdo (referência: paciente em decúbito dorsal), sem contaminar cirurgiã/equipe ou materiais; e permitir entrada na cabeceira da paciente (lipoaspiro as laterais do tórax – frente e dorso- nesta posição);
- Checar e ligar os equipamentos que utilizaremos (Infiltrador/ Vaser / renuvion);
- Solicitar e checar materiais provenientes da farmácia;
- Aquecer Soro Fisiológico 1000ml à 35/36 graus, 04 a 06 unidades para frente e costa (PS: AS SOLUÇÕES DEVEM SER PREPARADAS SOMENTE NO MOMENTO DE USO, EVITAR DEIXAR AS 08 OU 06 SOLUÇÕES TODAS PRONTAS (FRENTE E DORSO) – PERDA DE VIDA MÉDIA DA ADRENALINA E RISCO DE CONTAMINAÇAO).
- A cada 1000ml de Soro Fisiológico, colocar 03 adrenalinas e 01 transamin e 1 Ropivacaina 10mg.
- Manter essas soluções cobertas e o mais aquecidas possível (PS: somente preparar as 04 unidades que utilizarei para iniciar a cirurgia);
- Irrigador em 100% das lipos, portanto, colocar uma pequena quantidade de solução em cuba ou jarro, para infiltração da cicatriz;
- **Materiais a serem solicitados: CME**
- Solicitar do hospital 02 campos estéreis de panos;
- Solicitar do hospital 04 campos estéreis descartáveis (Impermeável) (fornecidos pela CME);
- Separar aventais estéreis de pano 04/06 unidades (fornecidos pela CME);
- Solicitar do hospital 01 caixa de pequena cirurgia ou uma caixa basica;
- Solicitar 03 cuba rim e um jarro (se tiver);
- Solicitar 01 cuba rim;

- Solicitar 03 extensões de látex (as mangueiras da lipo), preferencialmente compridas, fornecidas pelo hospital;
- Solicitar micropore estéril: médio (se o hospital for VALORE-DAY)
- **Materiais do Dr Ary**
- 01 caixa de mama e abdome;
- Separar o Kit de cânulas faga grandes;
- Separar o Kit de cânulas faga caixa pequena;
- Separar a caixa de Vibrofit;
- Separar o Kit de cânulas aviaro (para enxerto);
- Separar 01 decantador de gordura estéril e descartável (de acrílico FAGA);
- Separar a caixa do Vaser (peça de mão não vem esterilizada, fica separada na mala em uma bolsinha do Dr Ary;
- Sempre levar micropore estéril: médio (trazer da clínica edeixar na mala par uso)
- Solicitar 01 material de cateterismo vesical (para sondagem vesical em sala), fornecida pelo hospital.
- Afastador de Abdome (ponta azul, caso tenha abdome ou mini)
- Canet estéril (se **for hospital VALORE-DAY** , usar a nossa)
- Vicryl Rapid 3.0 (agulha grande) = 10 unidades (se for hospital **UNIMED**, usar nosso)
- Mononylon 4.0 INCOLOR (agulha pequena) (Se for Valore, usar deles)

Materiais a serem solicitados: FARMÁCIA

- Ampolas de adrenalinas = 20 unidades
- Ampolas de Transamin = 08 unidades

- Lâminas de bisturi n 15 = 06 unidades
- Lâminas de bisturi n 23 = 02 unidades
- Drenos de suctor 4.8 = 02 unidades
- Mononylon 3.0 (agulha grande) = 10 unidades
- Mononylon 2.0 (agulha grande) = 10 unidades
- Mononylon 5.0 (agulha pequena) = 06 unidades
- Mononylon 4.0 (agulha pequena) = 10 unidades
- Mononylon 4.0 INCOLOR (agulha pequena) (Se for unimed levar nosso) = 10
- Vicryl Rapid 3.0 (agulha grande) = 10 unidades (se for hospital Valore- day, usar deles)
- Azul de metileno = 02 unidades
- Soro Fisiológico 0,9% 1000ml = 08 unidades (solução)
- Ropivacaína 10% = 08 ampola
- Transofix = 02 unidades
- Ampolas de gentamicina = 02 unidades **(SE TIVER MAMA NO PROCEDIMENTO usar soro de 1000ml)**
- Ampolas de Clindamicina = 02 unidades **(SE TIVER MAMA NO PROCEDIMENTO, usar soro de 1000ml)**
- Compressas = 20 unidades (pacotes)
- Gaze estéril = 20 unidades (pacotes)
- Luva 7,5 = 08 unidades
- Luva 7.0 = 08 unidades
- Luva 8,0 = 08 unidades
- Ataduras estéreis número 15 ou 20 = 02 unidades (caso tenha lipo dos braços)
- Clorexidina alcoólica = 1 litro (sempre orientar circulante em jogar no braço do Dr após lavagem de mãos;

- Seringas de 50 ml = 6 unidades (bico) BD
- Seringa de 50ml = 2 unidades (com rosca)
- Seringas de 20ml C/ rosca = 4 unidades
- Seringas de 10ml C/ rosca = 08 unidades
- Serigas de 5ml C/ rosca = 8 unidades
- Seringa 3ml C/ rosca = 2 (aspirar azul)
- Seringa Insulina = 1 (para aspira Insulina NPH)
- Agulha rosa = 04 unidades
- Abocath n 18 = 2 unidades
- Pompons grandes = 08 unidades

Preparo da Mesa Cirúrgica:

- Utilizar campo impermeável por baixo e posteriormente, utilizar os campos estéreis fornecidos pelo hospital.
- MUITO cuidado com contaminação, evite abrir o material e deixá-lo aberto por muito tempo, caso o faça, o cubra com campos estéreis;

Evite montar a mesa cirúrgica apenas com luvas estéreis, isso pode contaminar a mesa, material etc. Realizar paramentação completa para montar a mesma!

Admissão de Paciente na Sala:

- **ATENÇÃO:** manter o ar da sala desligado ou aumentar temperatura para prevenir hipotermia e favorecer a temperatura adequada para a cirurgia, somente ligar ou diminuir após início da cirurgia, habitualmente a paciente vem marcada do RPA;
- Paciente ao ser admitida em sala deverá: deitar-se na maca com a camisola (tirar a camisola somente após a paciente estar com cobertas e lençol,

preservar a privacidade, e deixa-la mais confortável possível);

- Colocar meias compressivas na paciente, (Ela trás do quarto)
- Proteger joelhos e proeminências ósseas (utilizar coxins)

Preparo da Paciente:

- Posicionar a paciente em decúbito dorsal para procedimentos de punção venosa, monitoramento, sedação e anestesia, sondagem vesical de demora, após o Cirurgião definirá o primeiro debuto ou posição cirúrgica;
- Antes do posicionamento de decúbito ventral: checar se meias postas, bota pneumatica instaladas;
- Ao virar a paciente, cuidado com a sonda vesical (tração), utilizar travesseiros e coxins e colocar abaixo das pernas (mantê-las elevada), proteger o joelho com os coxins;
- Cuidar para que os dedos dos pés não toquem o colchão, devem estar flutuantes, checar no decorrer da cirurgia é imprescindível;
- Degermar a paciente com clorexidina degermante e luva estéril, limpar com compressa seca e estéril;
- Pintar o quadrante cirúrgico com clorexidine alcoólica em abundância;
- O procedimento de Lipoaspiro nos braços (caso tenha) devem ser deixados abertos com os cotovelos expostos e antebraço totalmente coberto e móvel com campo estéril, o mesmo campo estéril também deverá estar por baixo do braço (recomendo, nesta parte, usar campos de pano por baixo e posteriormente cobrir, embaixo e as laterais com o campo impermeável descartável, os antebraços devem ser totalmente cobertos com campos);
- Na parte inferior da paciente, utilizar dois campos de pano estéreis, um de cada lado (não deixar a mesa cirúrgica a mostra, a colocação geral dos campos deve cobrir a mesa em sua totalidade, após utilizar o campo inferior descartável por cima dos campos de pano estéril;

- Na Porção superior da paciente: campo estéril superior ombros expostos (fazer um reforço com ponto de mononylon 3.0 para fixarmos um pouco mais o campo);

- Ao iniciar a cirurgia, comunicar a família ou responsável do início do procedimento. A comunicação deverá ocorrer a cada 1:30 minutos ou conforme o andamento da cirurgia, sempre lembrar a markerting.

Preparo da Gordura:

- Lavar com soro fisiológico;
- Utilizar 01 soro de 1000ml com antibiótico e 2 gentamicina ;
- Quebrar a gordura com o kit da caixa pequena da faga ou seringa 50ml c/ rosca;
- Transferir a gordura para seringas de 10ml e 50 ml c/ bico e deixar preparada para lipoenxertia;
- Evitar abrir o frasco da gordura;
- Deixar cânula de Viaro preparada para o uso nesta etapa (enxerto o glúteo, ou abbdome (caso precisse ultrassom, deixar preparado);
- Nesta etapa, manter canula sempre limpas com clorexidina alcoolica para enxertia;
- Atenção e vigilância sobre a quantidade de compressas e acanulas em sítio cirúrgico;
- Na lipo dos cotovelos sempre dar um ponto de monoylon 5.0 e deixar meios folgados, o curativo com pompom e ataduras estéreis devem ser feitos para virada (mudança de posição);
- O dreno de 4.8, será fixado com mononylon 2.0; mononylon 5.0;
- Curativos devem ser feitos com cola Dermabond e microporagem estéril.
- Ao virar a paciente e trocar todos os campos, posicionar novamente (travesseiros embaixo dos joelhos, calcanhares livres), realizar degermação e lavagem das mãos cirúrgica a temperatura da sala deverá

ser aumentada de modo prevenir hipotermia, axilação da temperatura corporal ou choque térmico;

- Pintar novamente com clorexidina alcoólica em abundância e segurança de cobertura em 100%, sem deixar ilha, utilizar os campos de pano e estéreis da mesma forma que descrito previamente, porém, nesta etapa, habitualmente os braços ficarão totalmente cobertos; **(CASO TENHA MAMA, FICARÃO AO LONGO)**
- Trocar de luva **TODA VEZ QUE PINTAR E VIRAR PACIENTE**, mesmo que a equipe não saia de campo é recomendável;
- Ao término da cirurgia, realizar os curativos utilizando da tecnologia recomentada como: Cola Prineo em **(abdome ou mamas, caso tenha)** ;
- Ao terminarmos, atenção quanto aos equipamentos utilizados para a cirurgia, atenção com a bala do gás Hélio;
- Realizar desinfecção dos equipamentos e cabos com álcool 70% e compressa;
- Os instrumentais deverão ser lavados pelo instrumentadores. Os instrumentais do hospitais serão deixados no CME, os instrumentais do Dr. Ary com esterilização recomendada para Estericap, serão protocolados e levados até lá;
- opsite ou curativo oclusivo com gaze esterial e filme;
- Ao terminarmos, atenção quanto aos equipamentos utilizados para a cirurgia, atenção com a bala do gás Hélio;
- Realizar desinfecção dos equipamentos e cabos com álcool 70% e compressa, organizar a torre e trancá-la;
- e entregue a equipe do CME do hospital que

Controle de revisões			
Rev.	**Data**	**Revisão efetuada**	**Responsável**
00	27/04/2026	Emissão inicial	Lana Carolina

Elaboração	*Análise Crítica e Aprovação*
Nome: Lana Carolina **Data:** 27/04/2026	**Nome:** Dr Ary Leite **Data:**